

Fecha Última Actualización: 29-11-2022 8:48:43

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Hortensia Del Carmen Sanchez Moraga **Rut** : 7.314.780-8 **N° Archivo** : A148717
Edad : 66a 6m 14d **Fecha Nacto**: 15/05/1956 **Sexo** : Femenino
Dirección : Psje La Cadena 01567 V Chiloe **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 3354 6127

N° Epicrisis
305984

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion **Fecha Ingreso** : 04/05/2022 10:31 **Días Estadía**: 209
Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso) **Fecha Egreso** : 29/11/2022 08:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Fiebre

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

- Antecedentes:
- Médicos: DM2 IR, obesidad, dolor regional complejo muñeca derecha
 - Quirúrgicos: Colectistomizada, fractura muñeca derecha
 - Alergias: No
 - Fármacos: AAS, omeprazol, insulina
 - Hábitos: No
 - Inmunizaciones: COVID (3)

Consulta el día 03/05 en SU por cuadro de 72 horas de evolución de fiebre hasta 38°C, dolor abdominal, evolucionando con aparición de vesículas/flictenas en piel de dicho territorio, con mal olor, y compromiso de conciencia. Destaca al ingreso al examen físico alteración en región inguinal izquierda con placa con vesículas con contenido purulento y algunas con aspecto necrótico.

Del estudio al ingreso destaca TC AP (04/05) con hallazgos compatibles con fascitis necrotizante en el tejido celular subcutáneo y en planos musculares de la pared abdomino-pelvis lateral y posterior izquierda, con extensión hacia la región ínguido-femoral y perineal izquierda. Al laboratorio láctico elevado, PCR 412.5, anemia leve normocítica/hipocrómica, trombocitosis, AKI KDIGO I, hiponatremia moderada, hiperkalemia y acidosis metabólica. En ese contexto ingresa a hospitalización a cargo de cirugía. Se inicia terapia antibiótica con Ceftriaxona y Clindamicina, previa solicitud de hemocultivos (negativos).

Diagnósticos de ingreso a hospitalización:

1. Sepsis de foco perineal/inguinal/tejido subcutáneo y muscular abdominal:
 - Gangrena de Fournier/fasceitis necrotizante
2. AKI KDIGO I
3. Anemia leve

Se realiza primera exploración quirúrgica el día 04/05, con resección de pared abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, en tercio proximal de muslo izquierdo hasta fascia además del labio mayor izquierdo, extensa necrosectomía (sin acceso a peritoneo) y aseo con abundante cantidad de jabón y suero fisiológico. Durante pabellón evoluciona con requerimiento de DVA, por lo que se traslada al egreso a la UCI.

Fecha Epicrisis : 29/11/2022 08:48

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 29-11-2022 8:48:43

Página 2 de 3

Nuevos aseos quirúrgicos el 09/05, 16/05, 23/05, 04/06 y 15/06.

Evolución durante hospitalización por planes:

HEMODINAMIA: Al ingreso en UPC y posterior a primeros aseos quirúrgicos, se describe con requerimiento de dosis moderadas de DVA, con requerimientos posteriores intermitentes principalmente en relación a interurrencias infecciosas. Como última interurrencia a destacar cursó con PCR estando en cirugía A (obs. PCR de etiología hipóxica), encontrándose comprometida de conciencia sin respuesta al estímulo y sin pulso, con ROSC tras 1 ciclo, con req. de DVA moderados/altos, trasladándose nuevamente a UCI, destacando en estudio (TC 23/10) focos de condensación en ambos lóbulos inferiores y alza de parámetros inflamatorios, indicándose terapia antibiótica con mejoría progresiva y disminución de soporte respiratorio.

Durante últimas jornadas se describe taquicardia en relación a sepsis, fiebre persistente, pérdidas aumentadas y sospecha de sd serotoninérgico. Sin respuesta a ATB, antipiréticos, BZD, o hidratación enteral y parenteral (hiperNa y lactacidosis persistente). Se mantiene aporte de agua, medidas físicas y BZD para manejo sintomático.

HEMATOLOGÍA: Al ingreso en laboratorio con anemia leve, evoluciona con anemización durante hospitalización, requiriendo múltiples TR de GR durante estadía. No se describe durante estadía sangrado activo, impresiona anemización en contexto de múltiples req. de aseos quirúrgicos en pabellón, sepsis/shock séptico e inflamación. Última TR de 1 UI GR el 25/10.

VENTILATORIO: Al ingreso VMI en contexto de aseo quirúrgico, egresando a UCI dado evolución con requerimiento de DVA en dicho pabellón. Se realiza TQT quirúrgica el 18/07. En registro clínico se describen reingresos a UCI en contexto de requerimientos de aseo en pabellón, episodios de obstrucción de vía aérea por broncoespasmo dado decanulación accidental y reposicionamiento de dispositivo con cuff inflado, y múltiples interurrencias infecciosas. Tras dificultad para avanzar en proceso de decanulación, evaluada por ORL: (08/09) se realiza NFC visualizándose abundantes secreciones seromucosas en tráquea proximal con movilización parcial al toser y cánula de TQT con abundantes secreciones circulantes, se sugiere mantener TQT dado mal manejo de secreciones y continuar rehabilitación por FNA/KNT.

Evoluciona con mala mecánica en contexto de falla multiorgánica y drive ventilatorio aumentado por fiebre. Considerandose lo anterior, en UTIM se inicia BIC de fentanyl para manejo de confort, logrando regular mecánica y síntomas.

QUIRÚRGICO: Desde el ingreso múltiples requerimientos de aseo en pabellón debido a fascitis necrotizante/gangrena de Fournier, con dificultad de cobertura de defecto de pared abdominal dado extensión de éste. Último aseo quirúrgico fue el 15/06/22. Se mantiene con curaciones avanzadas de herida operatoria, y se encontraba en plan de reparación por cirugía plástica, cuando evoluciona con candidemia (C. glabrata).

Mantiene gran defecto de pared abdominal tras aseo Qx, además LPP sacra grado III con colección profunda. No candidata a resolución quirúrgica por desnutrición.

NEFROLÓGICO: Sin dato de creatinina basal, al ingreso destaca AKI KDIGO I. Cursa durante estadía en UPC con disociación de BUN/Creatinina y tendencia a la hipernatremia e hipercloremia, con poliuria concomitante. Se indica aporte de agua libre por SNG y por vía parenteral, además de desmopresina dado sospecha de diabetes insípida central vs. nefrogénica (ev. 06/07). Sin req. de TRR durante estadía. Evoluciona con AKI KDIGO3 e hipernatremia en contexto de falla multiorgánica. Se desiste de HD aguda por proporcionalidad.

INFECTOLÓGICO: Ingresa cursando sepsis con cuadro y hallazgos imagenológicos compatibles con gangrena de Fournier. Desde entonces, ha cursado con múltiples interurrencias infecciosas y gérmenes resistentes aislados en estudio, evoluciona con defecto de cobertura, múltiples aseos quirúrgicos, múltiples NAVM por BGN MR (PSAE MR, ACBA MR, KPN KPC NDM), múltiples bacteriemias (SAMR, KPN BLEE MR con NDM, St. mitis y KPN KPC) y fungemias (por Candida albicans y glabrata), sin lograr superar hits infecciosos antes de incurrir en uno nuevo.

Del 04/11 recibiendo Colistin + Linezolid + Fluconazol, cubriéndose ACBA MR + SAMR en CAET (01/11) y posible infección fúngica invasora dado fungemias subestudiadas.

Cintigrama óseo con hallazgos que pudiesen corresponder a fenómenos reactivos a fascitis necrotizante conocida y/o a proceso infeccioso óseo activo. Finalmente se descarta fungemia concluyendo estudio con RNM pelvis que descarta osteomielitis.

Se mantiene febril persistente desde el 14/11, sin aislar MB, se escaló el 17/11 a Ceftazidime/Avibactam + Aztreonam, manteniendo Linezolid y Fluconazol.

El 20/11 con PCR en 3, fiebre persistente sin respuesta a antipiréticos, lactacidemia, hipernatremia, falla renal, se presume posible sd serotoninérgico 2° a linezolid + sertralina, por lo que se plantea ventana antibiótica. 21/11 se reinicia Ceftazidime/Avibactam + Aztreonam, dado CAET (+) PSAE MR y colección en LPP sacra. Se toma Toxina CD (-) 14/11 y 22/11, dado SDA importante.

Evoluciona con FOM, febril persistente sin respuesta a terapia médica, severamente desnutrida, no candidata a intervenciones quirúrgicas, con poca posibilidad de rehabilitación y red de apoyo frágil para sus cuidados. Frente a lo anterior y futilidad en tratamiento ATB, se decide adecuar medidas terapéuticas.

NUTRICIÓN: procesos inflamatorios crónicos a repetición, además LPP sacra y defecto de pared no resuelto. Desnutrición CP severa sin respuesta a medidas establecidas.

Fecha Epicrisis : 29/11/2022 08:48

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 29-11-2022 8:48:43

Página 3 de 3

En suma, hospitalización prolongada en contexto de múltiples hits infecciosos, secundarios a Gangrena de Fournier y fasciitis necrotizante, con múltiples requerimientos de asépsis quirúrgica y falla a tratamiento a pesar de múltiples esquemas ATB, por lo que se decidió adecuación del esfuerzo terapéutico. Paciente se traslada a SMB para manejo de fin de vida. Se da aviso a familiares quienes acuden a visitar. Fallece el 26/11 a las 17:20, se da aviso a familiares y se entrega certificado de defunción.

Diagnóstico de Egreso

OTRAS SEPSIS ESPECIFICADAS - Fasciitis necrotizante abdominal

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecida

Plan Post Alta

Fallecida

Indicaciones

Tipo de Reposo :

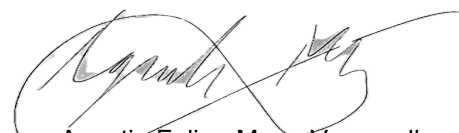
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Agustín Felipe Muga Vaccarella
Médico Tratante (Staff)